המועצה המדעית
SCIENTIFIC COUNCIL
ההסתדרות הרפואית בישראל
Israeli Medical Association

המועצה המדעית ועדת הבחינות

בחינות שלב א'

גריאטריה - בסיס

12.06.25

מס' השאלות בחלק זה:150

בחינת שלב א' גריאטריה בסיס 12.06.25

1. אילו מההתערבויות הבאות יכולה לסייע ל- Osteoarthritis בכף היד?
   א. ירידה במשקל
   ב. טאי צ'י
   ג. TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation)
   ד. חימום או קירור מקומי

2. איזה מהשינויים הפיזיולוגיים הבאים מאפיין את מערכת הלב וכלי הדם בזקנה?
   א. קיצור של PR ו- QRS
   ב. התפתחות של היצרות מסתמים
   ג. עליה בקשיחות (Stifness) של חדר שמאל וירידה בהרפיה דיאסטולית
   ד. הרחבת עורקים וירידה בהיענות (impedence) של האאורטה

3. בת 79, בבדיקות דם התגלה קריאטינין 1.1מ"ג/דל' (GFR מחושב 51.1). בבדיקה קודמת לפני כשנה קריאטינין היה 0.8 מ"ג/דל". ללא תלונות אורינריות או אחרות. מה יהיה ההסבר הנכון למצבה?
   א. יש התדרדרות טבעית בתפקוד הכלייתי עם הגיל, ולכן עליה קלה בקריאטינין אינה מצביעה על פתולוגיה כלייתית
   ב. למרות ירידה טבעית ב-GFR עם הגיל, יש גם ירידה במסת שריר ולכן קריאטינין היה אמור להישאר יציב ולא לעלות
   ג. ה-GFR בשאלה מחושב לפי נוסחת Cockcroft-Gault, ואילו על פי MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) הוא תקין ולכן לא תומך בפתולוגיה כלייתית
   ד. מדובר במחלת כליה כרונית (CKD) דרגה 2 לפי KDIGO ודרוש המשך מעקב עם איסוף שתן 24 שעות לחלבון

4. בן 84 הגיע ליעוץ גריאטרי עקב ירידה קוגניטיבית שהחמירה בחודש האחרון. כמו כן מתלונן על תופעות חדשות של עצירות, טשטוש ראיה ויובש בפה. מספר שהיה לפני חודש במרפאת כאב והחל תרופה חדשה במינון נמוך.
איזו תרופה חדשה שקיבל יכולה להסביר את התסמינים שלו?

   א. AMITRIPTYLINE (ELATROL)
   ב. VENLAFAXINE (VIEPAX)
   ג. DULOXETINE (CYMBALTA)
   ד. GABAPENTIN

5. מה מהווה גורם לפרוגנוזה ירודה ב- Acute Myeloid Leukemia (AML) בזקנים?
   א. שכיחות נמוכה של קריוטיפ -5q -7q
   ב. ביטוי מופחת של מסלולי TNF ו- RAS במח העצם
   ג. שכיחות גבוהה של MDS ברקע
   ד. רגישות מוגברת לאפופטוזיס של התאים הבלסטים

6. בת 82 התקבלה לשיקום לאחר ניתוח החלפה מלאה של מפרק ירך ימין בעקבות שבר אוסטאופורוטי. ברקע: מחלה ריאתית חסימתית כרונית, אי ספיקה לבבית כרונית עם מקטע פליטה 55%, יתר לחץ דם, סוכרת, השמנת יתר. בבדיקות מעבדה שנלקחו לבירור מעבדתי של אנמיה נצפו התוצאות הבאות: TSH = 40 mIU/L (נורמה 0.35-4.5), FT4 = 8 pmol/L (נורמה 10-20). כמו כן מדווחת על עצירות, חולשה כללית, וירידה בזיכרון לטווח קצר.
מהי הגישה הטיפולית המתאימה?
   א. התחלת טיפול ב- LEVOTHYROXINE (ELTROXIN) במינון 100 מק"ג ליממה
   ב. ממצא אופייני לאחר שבר בצוואר הירך, לא מצריך טיפול, מומלץ לחזור על הבדיקה לאחר השיקום
   ג. התחלת טיפול ב- LEVOTHYROXINE (ELTROXIN) ובדיקת מעקב חוזרת לאחר שבועיים
   ד. התחלת טיפול ב- LEVOTHYROXINE (ELTROXIN) עם יעד TSH של 4-6 mIU/L

7. מטופל הגיע לאשפוז בעקבות אצירת שתן ובלבול לאחר שהתחיל לאחרונה תרופה נגד דיכאון.
איזו תרופה סביר להניח שהתחיל לקבל?
   א. CITALOPRAM (RECITAL)
   ב. ECITALOPRAM (CIPRALEX)
   ג. PAROXETIN (PAXXET)
   ד. LUSTRAL (SERTRALINE)

8. מהם ההבדלים בין דלירים לבין התקף פסיכוטי?
   א. בדלירים החולה ערני ובהתקף פסיכוטי החולה שקוע
   ב. בדלירים הזיכרון תקין ובהתקף פסיכוטי הזיכרון לקוי
   ג. בדלירים החולה מתמצא בזמן ובמקום ובהתקף פסיכוטי לא
   ד. בדלירים אופייני הזיות ויזואליות ובהתקף פסיכוטי שמיעתיות

9. מבין המדינות הבאות היכן תוחלת החיים הגבוהה ביותר על פי לקט הנתונים האינפוגרפי של מכון ברוקדייל?

א. מונקו

ב. מקסיקו

ג. ישראל

ד. צ'אד

10. בן 80, עם רקע של דמנציה לפי אבחון גריאטר בקהילה לפני כחצי שנה, התקבל למחלקה גריאטרית לבירור נפילות חוזרות.

בבדיקה נוירולוגית - נוקשות יתר, איטיות בתנועה, עצבים קרניאליים – סימני Gaze Palsy.

אטרופיה של איזה איבר יכולה להסביר את ההסתמנות הקלינית?

א. Dorasl Midbrain

ב. Frontal Lobe

ג. Hypocampus

ד. Temporal Lobe

11. בן 67 אובחן לאחרונה עם מחלת פרקינסון. הוא מעוניין להתחיל טיפול תרופתי. איזו תופעת לוואי יותר נפוצה בטיפול ב- Levodopa מאשר בטיפול באגוניסטים לדופמין?

א. בצקת בקרסוליים

ב. ישנוניות בשעות היום

ג. הלוצינציות

ד. פלוקטואציות מוטוריות

12. בת 83, דיירת דיור מוגן, עצמאית ושמורה קוגניטיבית. מגיעה למיון בשל צריבה במתן שתן, חולשה כללית והקאות. בבדיקתה: חום 39 מעלות, דופק 105, לחצי דם 100/60. בבדיקת סטיק שתן חיובי ללויקוציטים וניטרטים. בבדיקות מעבדה עלית קריאטינין ל- 1.7 mg/dl. פינוי כלייתי מחושב 23.

איזה טיפול אנטיביוטי מתאים?

א. P.O NITROFURANTOIN (MACRODANTIN)

ב. I.V CEFTRIAXONE (ROCEPHIN)

ג. P.O FOSFOMYCIN (MONUROL)

ד. I.V CHLORAMPHENICOL (SYNTOMYCIN)

13. בן 65, גרוש, ערירי, גר לבד. רקע של שימוש מוגבר באלכוהול. אושפז בפנימית לאחר שנמצא ברחוב עם היפותרמיה. בקבלתו למיון מוזנח, מלוכלך, עם פצעים מרובים ברגליים. במהלך האשפוז יוצא לעשן בחצר וחוזר למחלקה. נפל פעם אחת במחלקה, ללא חבלות משמעותיות. הפצעים ברגליים על רקע אי ספיקת לב ורידית ובצקת. רובם שטחיים אולם יש 2 פצעים עמוקים מכוסים רקמת פיברין. לאחר התייצבות מצבו עו"ס מתרשמת שאינו יכול לחזור לגור לבד והמחלקה מזמינה ייעוץ גריאטרי לצורך הגדרה מוסדית. בשיחה המטופל מתמצא בסיטואציה ומסכים לעבור למסגרת מוסדית. האחיות מדווחות כי הוא שולט על סוגרים, זקוק לעזרה קלה ברחצה ולבוש פלג גוף תחתון. מתהלך במחלקה. הומלץ על הליכון אך לרוב לא משתמש. מה ההגדרה התפקודית המתאימה?

א. סיעודי מורכב
ב. סיעודי
ג. תשוש
ד. תשוש נפש

14. מי מהבאים בסיכון מוגבר לפתח תסמונת היפראלגזיה (רגישות מוגברת לגירויי כאב) הקשורה בטיפול באופיואידים (Opioid Induced Hyperalgesia)?

א. חולים עם תסמונת כאב כרוני המקבלים טיפול באופיואידים במינון גבוה
ב. חולים נאיבים (שלא טופלו עד כה באופיואידים) בזמן טיטרציה הדרגתית של הטיפול
ג. חולים המטופלים באופיואידים במינון נמוך
ד. חולים המפסיקים טיפול באופיואידים באופן פתאומי

15. בן 69, מהנדס אלקטרוניקה, עדיין מנהל את העסק העצמאי שלו. פנה למרפאה הגריאטרית עקב ירידה בזיכרון. לדבריו מתקשה לזכור תוכניות, משתמש ברשימות וסימונים על לוח השנה. Montreal Cognitive Assessment (MoCA) 25/30, נקודות ירדו על זיכרון לטווח קצר-בינוני. Geriatric Depression Scale (GDS) 2/15.
המטופל הגיע להתייעצות לגבי טיפול ביולוגי. מה ההמלצה על פי המאמר " Lecanemab in Early Alzheimer's Disease" מאת van Dyck et al?

א. יש לבצע בדיקה גנטית לאלל לגן ApoE4 ובמידה ונמצא הומוזיגוטי הטיפול מומלץ
ב. במידה ויקבל את הטיפול צפוי שיהיה שיפור ב- CDR-SB אך לא ברור אם תהיה לכך משמעות קלינית
ג. הטיפול אינו מתאים למצבו הקוגניטיבי הנוכחי, במידה ויפתח דמנציה יש להתחיל טיפול
ד. הטיפול מעלה תמותה בעקבות סיכון לדימום מוחי ולכן אינו מומלץ

16. באיזה מהבאים מתואר קשר נכון בין רפלקס פתולוגי לפגיעה המוחית הקשורה אליו?
   א. Babinski Reflex - פגיעה ב- LOWER MOTOR NEURON
   ב. Grasp Reflex - פגיעה באונה פרונטלית
   ג. Suck Reflex - פגיעה באונה אוקסיפיטלית
   ד. Palmomental Reflex – פגיעה מוחית דיפוזית

17. איזו אסטרטגיה בודדת הוכחה יעילה למניעת נפילות בקרב זקנים?
   א. שימוש במכשיר שמיעה
   ב. ניתוח קטרקט
   ג. תוספת ויטמין D באנשים החיים בקהילה
   ד. התאמת משקפיים על ידי אופטימטריסט מומחה

18. איזה מהשינויים הפיזיולוגיים הבאים בהזדקנות מהווה גורם סיכון להיפוגליקמיה?
   א. הפרשת גלוקגון מוגברת
   ב. עליה בתפקוד הרצפטורים הבטא אדרנרגיים
   ג. עליה בתגובת הורמון גדילה להיפוגליקמיה
   ד. פגיעה במערכת העצבית האוטונומית

19. איזה מהשינויים הפיזיולוגיים בהזדקנות הוא הנכון?
   א. יש תגובה מופחתת לסטרס פיזי או נפשי ("Fight or Flight") ללא עליה משמעותית ברמות קורטיזול
   ב. יש תגובה מופחתת להתייבשות, עם שמירה של נפח הפלסמה בגוף וירידה ב-GFR
   ג. יש תגובה מופחתת לשינויים ברמת גלוקוז בדם, עם רגישות גבוהה לתסמיני היפרגליקמיה
   ד. יש תגובה מופחתת למלאות בשלפוחית השתן, עם ירידה ביכולת ההתכווצות של שריר ה-Detrusor

20. בת 87, ברקע: דמנציה על רקע אלצהיימר, לאחר תיקון שבר בצוואר הירך דו"צ מרותקת לאחרונה למיטה, היפותירואידיזם. לאחרונה קשיי הזנה אוכלת כמויות קטנות דרך הפה.

בבדיקות המעבדה:

מדד ויחידות מידה	ערך לחולה	ערכי הנורמה
K mM/L	5.2	3.5-5
HgB gr/dL	10.5	12-16
Ferritin ng/mL	10	13-150
TSH mU/L	20.89	0.4-4

טיפול תרופתי:

Aspirin 100mg x1

Esomeprazole 40 mg x1

Mirtazapine 30 mg x1

Quetiapine 25 mg x3

Levothyroxine 150 mcgx1

CT בטן בתמונה מספר 1.

איזה מההתערבויות התרופתיות יכול לעזור בטיפול?

א. הפסקת הדרגתית של טיפול ב- Quetiapine

ב. הורדת המינון של Levothyroxine

ג. הוספת טיפול ב Kayexalate

ד. הוספת טיפול בברזל פומי

21. בת 78, התקבלה למחלקת שיקום לאחר אשפוז עקב אירוע מוחי עם שיתוק בפלג גוף ימין.

בבדיקתה פצע לחץ דרגה 3 בעכוז.

איזו מההתערבויות הבאות הוכחה כמשפרת ריפוי של פצע הלחץ באופן משמעותי?

א. שימוש במזרון דינמי

ב. טיפול בחמצן היפרבארי

ג. תוספת טיפול בוויטמינים A,E,C IRON

ד. אנטיביוטיקה סיסטמית

22. בן 75, לוקה בדמנציה מתקדמת, אובחן עם Aortic Stenosis במסגרת בירור כאבים בחזה.
באקו לב שטח מסתם $0.6\ cm^2$, מפל לחצים 50 mmHg, מהירות זרימה 5 m/s.
מה הגישה הטיפולית הנכונה למטופל?

א. Surgical Aortic Valve Replacement (SAVR)
ב. Transcatheter Aortic Valve Replacement (TAVR)
ג. טיפול פליאטיבי לצורך הקלת התסמינים
ד. בהעדר קריטריונים להתערבות לבצע בדיקה חוזרת בעוד שנה

23. במרפאה קרדיולוגית מעוניינים להכניס בדיקה לאבחון שבריריות שתתבצע לפני החלטה על פרוצדורת החלפת מסתם אאורטלי בצינתור Transcatheter Aortic-Valve Implantation (TAVI).
מה ההמלצה המתאימה בהתייחס למדדי שבריריות שונים?

א. מדד FRIED ניתן לבצע בתשאול טלפוני
ב. ניתן לבצע מדד Deficit Accumulation Index or Frailty Index (FI) אחרי הערכה כוללנית של גריאטר בקהילה
ג. במידה ורוצים להשתמש באבחון שבריריות מתוך תיק רפואי מומלץ להשתמש במדד Clinical Frailty Scale (CFS) של Rockwood
ד. מדד FRAIL מחייב בדיקה גופנית במרפאה

24. מה מאפיין הפרעות שינה בפיברומיילגיה?

א. עליה במשך השינה הכללי
ב. ירידה במשך שנת REM
ג. EEG יראה ירידה בכמות של גלי אלפא
ד. הירדמות מהירה ויקיצה איטית

25. למי מהמטופלים הבאים מתאים להיעזר ברולטור?

א. בת 72 הסובלת מ- Lewy Body Dementia
ב. בן 77, שמור קוגניטיבית, לאחר שבץ, סובל מפרזיס ביד ורגל ימין
ג. בן 85 הסובל ממחלת פרקינסון
ד. בת 88 הסובלת מ- Pulmonary Fibrosis וקוצר נשימה במאמץ

26. בזקן עם בעיית שמיעה על רקע הגיל, איזה מהמילים הבאות יתקשה לזהות?
   א. גלידה
   ב. שלום
   ג. ארון
   ד. ספר

27. מה מהבאים מקל על כאב שמקורו ב- Lumbar Spinal Stenosis
   א. ישיבה
   ב. הליכה
   ג. ירידת מדרגות
   ד. עמידה

28. בן 81, עם סרטן ריאות מתקדם, מאושפז במחלקה האונקולוגית לקבלת טיפולים כימותרפיים והקרנות. המטופל תשוש, מדווח על תאבון ירוד ואוכל מעט. בנוסף סובל מתופעות לוואי מהטיפולים שמקבל. מהי הגישה לגבי טיפולים תומכים במטופל זה?
   א. טיפול פליאטיבי משפר את איכות החיים של המטופל, אבל לא את ההישרדות הכללית
   ב. לתשישות המאפיינת מטופלים אונקולוגיים רבים אין טיפול פרמקולוגי
   ג. הטיפול בבחילות ניתן רק במידה ויש סימפטומים ולא כטיפול מונע
   ד. אם למטופל יש דיכאון סביר לתת טיפול ב- MIRTAZAPINE (MIRO)

29. מה מחשיד שנגע עורי הוא Malignant Melanoma?
   א. צבע כהה ואחיד
   ב. גבולות חדים ומורמים
   ג. אסימטריה
   ד. ריבוי נגעים עם מראה דומה

30. בת 74 מדווחת על בריחת שתן לאחר ניתוח החלפת ברך אלקטיבי. מציינת בריחת שתן בדרך לשירותים.
איזה מהתערבויות הבאות יכולה להפחית את אירועי בריחת השתן?
   א. טיפול תרופתי מקובצה של Alpha Adrenergic Agonist
   ב. תרגול של שלפוחית השתן (Bladder Training)
   ג. התאמת סביבה
   ד. התערבות כירורגית

31. מה מאפיין טיפול ב- Electroconvulsive Therapy (ECT) בגיל המבוגר?
   א. טיפול ב-ECT פחות יעיל בזקנים לעומת צעירים
   ב. טיפול ב-ECT בטוח עם מעט תופעות לוואי
   ג. טיפול ב-ECT גורם לירידה בזיכרון לטווח ארוך
   ד. שיעור תסמיני הדיכאון גבוה אחרי טיפול ב-ECT

32. בת 65, מדווחת שבשנתיים האחרונות קיימת החמרה ברעד וחוסר קואורדינציה של יד שמאל שהופיעה בעיקר בזמן נשיאת חפצים, כעת מודאגת מהאטה מילולית, מתקשה בשליפת מילים ויש פגיעה בשטף הדיבור. בבדיקה בולטת נוקשות ביד שמאל ומיוקלונוס בעת יישור היד השמאלית, דיסטוניה משמאל, לא נצפה רעד אך קיימת אי יציבות בעמידה והליכה.
מה האבחנה המתאימה?
   א. דמנציה מסוג Lewy Body
   ב. תסמונת Corticobasal
   ג. Primary Progressive Aphasia
   ד. מחלה על שם Creutzfeldt – Jacob

33. מה נכון לגבי פתופיזיולוגיה של דליריום?
   א. הפעלת המערכת הדופמינרגית
   ב. הפעלת המערכת הכולינרגית
   ג. דיכוי מערכת נוראפינפרין
   ד. אין שינוי במערכת סרוטונינרגית

34. בן 91 מתגורר בגפו. ברקע: סוכרת, יתר לחץ דם, אוסטיאוארטריטיס, ניוון רשתית (AMD) ,קטרקט ואנמיה על רקע תלסמיה מיינור. פנה לייעוץ גריאטרי בעקבות תופעה חדשה של ראיית דמויות אנשים וחיות בתוך ביתו. המטופל מודע לכך שמדובר בדמויות שאינן קיימות במציאות ומוטרד מהאפשרות שמדובר בתסמינים של דמנציה. בבדיקה גופנית: סימנים חיוניים תקינים, ללא ממצא חריג. במעבדה אנמיה יציבה, המוגלובין מסוכרר (A1C=6.8%). בדיקת MoCA 26/30 – נקודות ירדו בסעיפים של העתקת קובייה, שיום וזיכרון מושהה. מה האבחנה הסבירה?
   א. Charles-Bonnet Syndrome
   ב. Lewy Body Disease
   ג. Delirium
   ד. Schizophrenia

35. בן 75 עם רקע של מחלת פרקינסון, המטופלת ב- DOPICAR ודיכאון, המטופל ב- BUPROPION. הופנה לאשפוז בעקבות נפילה ושבר בצוואר ירך. בבירור לסיבת הנפילה המטופל ציין כי נפל מהמיטה בזמן שינה תוך כדי חלום בלהות.
מה הטיפול התרופתי המומלץ במצבו?
   א. טיפול ב- MIRTAZAPINE (MIRO)
   ב. טיפול ב- MELATONIN (CIRCADIN)
   ג. טיפול ב- OXAZEPAM (VABEN)
   ד. הפסקת טיפול ב- BUPROPION (WELLBUTRIN)

36. מה מאפיין Clostridium Difficile Infection (CDI) בזקנים?
   א. לזקנים עם CDI יש פרוטוקול טיפול שונה ביחס לצעירים
   ב. במטופלים זקנים בסיכון גבוה לפתח CDI לא מומלץ טיפול בנוגדנים
   ג. רוב הזקנים עם נשאות א-תסמינית יפתחו CDI לאחר טיפול אנטיביוטי
   ד. הסיכון להישנות של CDI גבוה יותר בזקנים ביחס לצעירים

37. כיצד מוגדר "אדם קרוב" לפי "חוק החולה הנוטה למות"?
   א. כל אדם שמכיר את החולה
   ב. רופא המטפל בחולה
   ג. אדם בעל קרבה משפחתית או רגשית לחולה ומסור לו
   ד. כל אדם שמבקר את החולה בבית החולים

38. בדמנציה מתקדמת שכיחה דיספגיה וירידה במשקל, וקיים סיכון לפתח דלקת ריאות מאספירציה (Aspiration Pneumonia). מה נכון לגבי הזנת צינור (Tube Feeding) בשלב זה?
   א. מגבירה את הסיכון להתפתחות פצעי לחץ
   ב. עדיפה על האכלה פומית
   ג. מונעת התפתחות דלקת ריאות מאספירציה
   ד. משפרת איכות חיים ותוחלת חיים

39. אילו שינויים פיזיולוגיים בזקנה עשויים לגרום לסיבוכים סביב ניתוחים?
   א. עליה בזרימת דם לכבד, ולכן ירידה בזמן מחצית חיים של תרופות שמפונות בכבד
   ב. עליה ב-V/Q mismatch, ולכן עליה בפוטנציאל לכשל נשימתי
   ג. עליה בהפרשת נתרן ומים, ולכן עלייה בסיכון להתייבשות
   ד. ירידה בהפרשת אינסולין, ולכן עלייה בשכיחות של היפוגליקמיה

40. מטופל בן 83 אובחן עם דמנציה על רקע מחלת אלצהיימר לפני כשלוש שנים. מתגורר בבית עם אשתו ועם מטפלת צמודה שמסייעת ב-IADL בעיקר, משגיחה במקלחת ומלווה את המטופל בהליכות בשכונה על מנת למנוע נפילות. ברקע: מחלת לב איסכמית, יתר לחץ דם, סוכרת סוג 2, איבוד שליטה על סוגרים מסוג Urge. נוטל ASPIRIN, ENALAPRIL, METFORMIN, FESOTERODINE, HYDROCHLOROTHIAZIDE.
מובא למרפאה על ידי המשפחה בשל הופעה של אי-שקט, אגיטציה, התנהגות אגרסיבית. משתולל כשמנסים להכניס אותו למקלחת או להחליף לו בגדים. בתשאול מתברר שלא אלים פיזית כלפי המשפחה או המטפלת, לא בורח מהבית ומצליחים להרגיע אותו בשיחה בדרך כלל.
לפי המאמר Reduction and prevention of agitation in persons with neurocognitive disorders: an international psychogeriatric association consensus algorithm מאת Cummings et al., מה השלב הבא בבירור והטיפול?

א. מומלץ על התחלת טיפול בתרופות אנטיפסיכוטיות
ב. מומלץ על התחלת טיפול ב-CITALOPRAM
ג. מומלץ להפסיק METFORMIN כיוון שעשוי להחמיר אגיטציה
ד. יש להבין את הסיבות לאגיטציה ולבנות תוכנית טיפול לפי עקרונות ה- DICE

41. בן 65, שוקל 80 קילו, אובחן עם תסמונת Guillain-Barré לאחר שהתייצג עם חולשה סימטרית עולה וא-רפלקסיה. לאחר 5 ימי טיפול ב IVIg-במינון 160 גרם ליום, לא נצפה שיפור משמעותי במצבו. מה ההחלטה הטיפולית הנכונה כעת?

א. להתחיל טיפול משולב של IVIg עם פלזמפרזיס להגברת יעילות הטיפול
ב. להחליף את הטיפול לפלזמפרזיס מכיוון שה- IVIg לא היה יעיל
ג. להמשיך מעקב ותמיכה נשימתית בהתאם לצורך, ללא שינוי בטיפול האימונומודולטורי
ד. לתת מחזור נוסף של IVIg במינון גבוה יותר

42. בן 75, ברקע: מחלת לב איסכמית ואי שליטה על השתן, נוטל מזה שנים ASPIRIN, VALSARTAN, ESCITALOPRAM, MIRABEGRON .
איזו מהתרופות שנוטל מעלה סיכון לנפילות?

א. ASPIRIN
ב. ESCITALOPRAM (CIPRALEX)
ג. VALSARTAN (VECTOR)
ד. MIRABEGRON (BETMIGA)

43. בת 76 מגיעה לביקור מרפאה יחד עם בעלה. ברקע אי ספיקת כליות סופנית (ESRD) ועוברת המודיאליזה בשנתיים האחרונות. בנוסף מחלת לב איסכמית, יתר לחץ דם, סוכרת סוג 2 ומחלת ריאות חסימתית כרונית. ניידת בצורה עצמאית עם הליכון, נעזרת בבעלה ל-IADL בלבד. ידוע על דמנציה וסקולרית קלה. המטופלת מרגישה התדרדרות בתפקוד ופונה למרפאה על מנת לקבל ייעוץ אודות שיפור איכות חיים ומניעת סיבוכים. מה נכון להמליץ לה?

א. במטופלים עם ESRD יש שכיחות גבוהה של נפילות, ולכן מומלץ להתחיל טיפול בביספוספונאט כמו ALENDRONIC ACID (FOSALAN) על מנת למנוע שברים.

ב. במטופלים מבוגרים עם ESRD יש שכיחות גבוהה של Renal Osteodystrophy, ולכן חשוב להיות אגרסיביים בטיפול על מנת למנוע שברים

ג. למטופלים עם ESRD יש שכיחות גבוהה של תת תזונה, במיוחד לאור ההגבלות התזונתיות השונות. מומלץ לעקוב אחר רמות אלבומין בדם ולפנות לייעוץ דיאטנית על מנת להתאים תפריט

ד. במצבה דיאליזה לא משפרת פרוגנוזה, ועדיף לתכנן הפסקת הטיפול כדי לשמור על איכות החיים

44. מהי ההמלצה הנכונה למניעת סוכרת במטופלים מעל גיל 65 עם טרום-סוכרת?

א. מומלץ לבצע שינוי אורח חיים לצורך דחיית ההתקדמות לסוכרת

ב. מומלץ לבצע בדיקת סקר לאבחון סוכרת אחת לשנה רק אם יש סיפור משפחתי של סוכרת

ג. מומלץ להתחיל טיפול תרופתי בגלוקומין כקו ראשון

ד. מומלץ על ירידה במשקל של לפחות 10%

45. בן 88 עם רקע של פרקינסון. ידוע על עצירות לאחר ניתוח החלפת ברך, אשפוז ממושך בעקבות דלקת ריאות, במהלך האשפוז נבדק בעקבות בטן תפוחה. בבדיקות המעבדה אשלגן 2.5 mmol/L (נורמה 3.5-5).

צילום בטן מצורף בתמונה 2.

בנוסף לתיקון אלקטרוליטים, הכנסת Rectal Tube מה הטיפול המומלץ?

א. Neostigmine (Mestinon)

ב. Polyethylene Glycol (Normalax)

ג. Bisacodyl (Laxadine) בכדורים

ד. Bisacodyl (Laxadine) בנרות

46. בת 93, אובחנה עם היפותרמיה (32 מעלות צלסיוס) לאחר נפילה ושכיבה ממושכת על רצפת ביתה.

מה מהבאים הוא הגורם המשמעותי ביותר להתפתחות היפותרמיה בגיל המטופלת?

א. ירידה בטמפרטורת הגוף הבסיסית (Basal Body Temperature)

ב. ירידה ביכולת יצירת חום במנגנון צמרמורת (Shivering)

ג. עליה ביכולת כיווץ כלי הדם הפריפריים (Vasoconstriction)

ד. ירידה במסת השומן הבטני (Abdominal adipose)

47. בן 82 , מאושפז במחלקה לסיעוד מורכב עקב פצע לחץ בעכוז עם ריבוי הפרשות. מצורפת **תמונה מספר 3.**

מה הוא הטיפול המומלץ?

א. POVIDONE IODINE (POLYDINE)

ב. מדבקת HYDROCOLLOID

ג. משחה אנטיביוטית מקומית

ד. HYDROFIBER עם יוני כסף

48. לאחר Mechanical Mitral Valve Replacement, מה הטיפול התרופתי המומלץ לדילול דם?

א. ASPIRIN

ב. CLOPIDOGREL (PLAVIX)

ג. APIXABAN (ELIQUIS)

ד. WARFARIN (COUMADIN)

49. בת 94 גרה לבד בביתה. ברקע: יל"ד ואי-ספיקת כליות - קראטינין בסיס 1.6, שוקלת 50 ק"ג ללא שינוי בשנה האחרונה. ללא אשפוזים בשנה האחרונה. היא מתארת עייפות, חוסר אנרגיה, והליכה איטית. בנוסף, מדווחת על 2 נפילות בשנה האחרונה.

על מנת להשלים מדד FRIED במרפאה מה צריך לבצע?

א. חישוב BMI

ב. ביצוע שאלון תזונתי מפורט

ג. ביצוע מדידת HAND GRIP

ד. ביצוע MoCA

50. בן 88, ברקע ידוע על COPD, ונעזר בחמצן ביתי, אושפז להשגחה לאחר נפילה ושבר בצלע. המטופל מתלונן על כאב חזק בחזה, באזור השבר. בדיקות הדם תקינות, כולל גזים, מדדי דלקת, ספירת דם, תפקודי כבד וכליה. המטופל מתלונן מאד על כאב, למרות טיפול ב- 1 גרם של PARACETAMOL תוך ורידי 4 פעמים ביום. מה נכון לגבי איזון כאב במטופל זה בעת האשפוז?

א. אין לתת טיפול ממשפחת ה- NSAIDS לנוכח גילו וסיכון לדימום ממערכת העיכול
ב. אין לתת טיפול באופיואידים בשל טיפול כרוני בחמצן והסיכון לדיכוי נשימתי
ג. אין לתת שילוב של PARACETAMOL עם NSAIDS
ד. אין לתת תוספת PARACETAMOL

51. מבין תוצאות מבחני התפקוד והניידות הבאים מה מנבא סיכון מוגבר למוגבלות בניידות?

א. מבחן LONG DISTANCE CORRIDOR WALK תוך 2 דקות מרחק של 300 מ'
ב. מבחן SIX MINUTE WALK מרחק 400 מ'
ג. מבחן TIME GET UP & GO במשך 25 שניות
ד. מבחן SHORT PHYSICAL PEFORMANCE BATTERY ציון של 12

52. בת 80 אובחנה עם ממאירות קולון מקומית, מועמדת לניתוח. לפי בירור טרום ניתוחי אין עדות לפיזור משני וככל הנראה לא יידרש טיפול אונקולוגי משלים לאחר הניתוח. לא ידוע על ירידה קוגניטיבית. המטופלת מבקשת למלא הוראות מקדימות טרם הניתוח. מה נכון?

א. מוגדרת כחולה הנוטה למות ונדרש החתמה על ידי רופא/ה בלבד
ב. נדרשת הערכת כשירות על ידי גריאטר טרם חתימה על ההוראות
ג. יכולה למלא רק ייפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות
ד. יכולה למלא טופס הנחיות רפואיות מקדימות בנוכחות אח/ות

53. בת 75, עצמאית ב- BADL וללא חסר קוגניטיבי. ברקע אוסטאופורוזיס, מטופלת בוויטמין D ו- ALENDRONATE. בנוסף יתר לחץ דם, שבחצי שנה האחרונה טופל עם דיאטה ופעילות גופנית, ללא טיפול תרופתי.

בשבועות האחרונים מספר מדידות של לחץ דם סביב 165/90.

מה הגישה הטיפולית הנכונה בחולה זו?

א. המטופלת עם סיכון קרדיו-וסקולרי נמוך ולכן אינה זקוקה לטיפול להורדת לחץ דם
ב. בגילה היעד להורדת לחץ הדם הסיסטולי הינו מתחת ל- 120 mmHg
ג. אוסטאופורוזיס הינו התוויית נגד לטיפול ב-Hydrochlorothiazide
ד. ככל הנראה תזדקק לשתי תרופות להורדת לחץ הדם

54. בת 92 סובלת מדמנציה בחומרה קלה, דיכאון ויתר לחץ דם. בתקופה האחרונה היא מרגישה כאב בטן תחתונה פתאומי, לחץ ללכת לשירותים, אך היא לא מצליחה להתאפק. לכן יש לה דליפות שתן בכמות קטנה בדרך לשירותים. איזו תרופה עלולה לגרום לתופעה זו?

א. DONEPEZIL (MEMORIT)
ב. VALSARTAN (VECTOR)
ג. AMIODARONE (PROCOR)
ד. BISOPROLOL (CARDILOC)

55. איזה מהבאים הוא גורם סיכון גבוה לממאירות במצב שבו יש ממצא של נודול בתירואיד?

א. מין נשי
ב. המצאות נודולים מרובים בתירואיד
ג. הסתיידויות בבלוטה בבדיקת סונר
ד. נודול שנמוש בבדיקה גופנית

56. בן 80 עם ירידה קוגניטיבית בשנה האחרונה, פנה עם אשתו למרפאה. הם מספרים כי בחודשיים האחרונים היו נפילות חוזרות ואירועים של אי שקט לסירוגין. המטופל מדווח שרואה חרקים במיטה, ואשתו מתארת הפרעות בשינה. מהו הטיפול התרופתי המומלץ במצב זה?

א. Amantadine (PK-Mertz)
ב. Donepezil (Memorit)
ג. Risperidone (Risperdal)
ד. Diazepam (Assival)

57. בת 90, גרה לבד בבית, תמיד היתה מאוד פעילה. לאחרונה מתלוננת על קושי לעשות עבודות בית קלות שבעבר הייתה עושה בקלות.

בוצע מבחן PHQ-9 המצורף **בתמונה מספר 4**

לפי המבחן מה האבחנה ומה הטיפול?

א. מדובר ב- Dysthymia, מומלץ התחלת טיפול תרופתי
ב. מדובר ב- Minor Depression מומלץ מעקב בלבד
ג. יש לחפש גורם אחר לעייפות, מעקב בלבד
ד. מדובר ב- Dysthymia, מומלץ טיפול פסיכותרפי

58. מה נכון בנוגע לתבחינים לאבחון Tuberculosis?

א. רגישות ה- Tuberculin Skin Test לא משתנה עם הגיל

ב. בדיקת Tuberculin Skin Test עשויה להיות חיובית לאחר חיסון BCG

ג. בדיקת Interferon Gamma Release Assay (IGRA) חיובית מאבחנת Latent Tuberculosis

ד. בדיקת IGRA מצריכה שני שלבים לצורך השלמתה

59. איזו התערבות רפואית מותרת מבחינה חוקית <u>בחולה הנוטה למות</u> <u>לפי רצונו</u>?

א. ניתוק ממכונת הנשמה

ב. ניטרול פעולה של ICD (IMPLANTABLE CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR)

ג. הפסקת פעולה של קוצב לב במטופל עם COMPLETE AV BLOCK

ד. מתן עירוי עם MORPHINE במינון כפול מזה המקל על כאבים

60. בן 80, נפל ושבר מפרק ירך וזקוק לניתוח. ברקע ידוע על פרפור עליות תחת טיפול ב- APIXABAN (ELIQUIS).

מהי ההרדמה המומלצת ומדוע?

א. הרדמה כללית, כי מאפשרת ניתוח מיידי

ב. הרדמה אזורית לאחר יומיים של הפסקת APIXABAN, כי מורידה סיכון לדליריום

ג. הרדמה אזורית לאחר יומיים של הפסקת APIXABAN, כי מפחיתה תמותה

ד. הרדמה כללית כי מפחיתה שימוש באופיואידים לאחר הניתוח

61. לפי המאמר Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission מאת Livingstone et al, מה מהבאים נכון?

א. אלל ApoE4 הוא גורם סיכון משמעותי לדמנציה ואין אפשרות להפחתת סיכון זה בהתערבות חיצונית

ב. ישנם 14 גורמי סיכון הניתנים לשינוי, התערבות ושיפור בהם מפחית סיכון לדמנציה במעל 60%

ג. מעכבי כולין אסטרז לא הראו יעילות משמעותית בהאטת התקדמות דמנציה של מחלת אלצהיימר, ובשל תופעות לוואי משמעותיות עדיף שלא להשתמש בהם

ד. במטופלים עם דמנציה על רקע מחלת גופיפי לווי (Lewy Body), יש לבדוק ביומרקרים ב- CSF על מנת לאשר את האבחנה

62. בן 75, לאחר אירוע מוחי ופגיעה בפלג גוף ימין.

בבדיקתו: ביד ימין - תנועה כנגד כוח הכבידה ולא כנגד תנגודת. ברגל ימין לא הופקה תנועה כלל.

איך מוגדר הכוח בגפיים?

א. רגל 0/5 יד 5/5

ב. רגל 1/5 יד 4/5

ג. רגל 0/5 יד 3/5

ד. רגל 1/5 יד 2/5

63. בן 86, מאובחן עם דמנציה מתקדמת, מאושפז במחלקה לסיעוד מורכב עקב פצעי לחץ בדרגה 4 בעכוז ובעקב, מוגדר כנוטה למות, פיתח דלקת ריאות מאספירציה, מה נכון לגבי הטיפול?

א. טיפול אנטיביוטי משפר הישרדות אך לא נוחות

ב. המטופל מוגדר כנוטה למות אין לתת טיפול אנטיביוטי

ג. יש להפסיק האכלה פומית ולהכניס זונדה למתן אוכל ותרופות

ד. יש להגדיר את המטופל כנוטה למות במצב סופי ולהתחיל סדציה פליאטיבית

64. מיפוי SPECT דופמין יעזור להבחין בין פרקינסון לבין איזו מהאבחנות הבאות?

א. Progressive Supranuclear Palsy (PSP)

ב. Dementia with Lewy Bodies (DLB)

ג. Essential Tremor

ד. Multiple System Atrophy (MSA)

65. בן 68 עם מחלת פרקינסון, שאובחנה לפני 6 שנים, מתמודד עם קושי הולך וגובר בזיכרון, קשב וקבלת החלטות. התסמינים המוטוריים של החולה יציבים, אך הירידה הקוגניטיבית הפכה בולטת יותר במהלך 6 החודשים האחרונים, מלווה בירידה בקשב , הפרעת שינה וליקוי ויזו-מרחבי.

איזו מהאפשרויות הבאות היא אופציה טיפולית של קו ראשון לטיפול בתסמינים של המטופל?

א. Levodopa

ב. Cholinesterase Inhibitors

ג. Dopamine Agonists

ד. Antipsychotics

66. מה נכון בנוגע למנגנון פיזיולוגי של שליטה בסוגר השתן?

א. מערכת סימפתטית גורמת להתכווצות של שלפוחית השתן

ב. מערכת פרה-סימפתטית גורמת להרפיית שלפוחית השתן

ג. מערכת סומטית גורמת להתכווצות של שרירי אגן

ד. מערכת סימפתטית גורמת להרפיה של השופכה

67. בת 77, לוקה בסרטן שד גרורתי ומקבלת מספר תרופות. באיזה מהבאים מתואר נכונה טיפול עם תופעת הלוואי הצפויה בעקבותיו?

א. LETROZOLE (FEMARA) – אי ספיקת כליות

ב. MEGESTROL ACETATE (MEGACE)– ירידה במשקל

ג. CYCLOPHOSPHAMIDE - ציסטיטיס

ד. METHOTREXATE - טרומבוציטוזיס

68. מה הסיבה השכיחה ביותר לתסמונת קושינג בקשישים?

א. טיפול תרופתי בקורטיקוסטרואידים

ב. אדנומה מפרישה של האדרנל

ג. קרצינומה מפרישה של האדרנל

ד. הפרשת יתר של ACTH מההיפופיזה

69. מהם העקרונות בהמלצה לטיפול בנוגד דיכאון?

א. כדי להגיע לתגובה טיפולית חשוב להגיע למינון מטרה של התרופה

ב. בטיפול בדיכאון מינורי מומלץ מינון נמוך של תרופות לעומת דיכאון מג'ורי מינון גבוה

ג. תרופות נוגדות דיכאון יעילות מאוד במטופלים עם דמנציה

ד. לטיפול נוגד דיכאון יש אפקט פלסבו גבוה

70. מה נכון לגבי דמנציה של עגבת (Syphilis)?

א. יכולה לקרות בכל שלב של המחלה

ב. טיפול בפניצילין לרוב מביא להחלמה

ג. התסמינים כוללים הזיות, דלוזיות, אטקסיה וירידה קוגניטיבית

ד. יש לבצע סקירה לעגבת לכל דמנציה חדשה, גם בנוכחות אטיולוגיה ברורה

71. בן 88, מתגורר בביתו עם מטפלת צמודה. ברקע: מצב אחרי אירועי מוחי, דמנציה וסקולרית, אירועי אגיטציה בתדירות יומית. בהמלצת קלינאית תקשורת מוזן בכלכלה דייסתית. נבדק בחשד לדלקת ריאות כתוצאה מאספירציה. בבדיקתו: חום 38 מעלות, היגיינת פה ירודה, חרחורים לחים בבסיס ריאה ימנית. בצילום חזה תסנין בבסיס ריאה ימנית.
מה מהבאים, במטופל זה, עשוי להפחית את הסיכון להתפתחות דלקת ראות כתוצאה מאספירציה?

א. הקפדה על היגיינת חלל הפה
ב. מתן טיפול אנטי-פסיכוטי להרגעה לפני האוכל
ג. החדרת צינור הזנה מסוג PEG
ד. טיפול מונע ב- AMOXICILLIN

72. בן 75, עם דומיננטיות ימנית התקבל עם אוטם ב- MCA, לפי המאמר Stroke Rehabilitation Clinician Handbook 2020 מאת Teasell et al, מהי הפגיעה הצפויה?

א. בפגיעה ב- RT MCA, בחלק המטופלים יתכן Neglect
ב. בפגיעה ב- RT MCA, צפויה אפאזיה גלובלית
ג. בפגיעה ב- LT MCA, צפויה פגיעה בראיה
ד. בפגיעה ב- LT MCA, צפויה פגיעה בולטת יותר ברגל בהשוואה ליד

73. מה הוא יעד הטיפול בסוכרת לקשיש סיעודי עם דמנציה מתקדמת שלא מקבל טיפול באינסולין?

א. סוכר בצום בין 90-130
ב. סוכר בצום בין 180-250
ג. ערך המוגלובין מסוכרר פחות מ-7%
ד. ערך המוגלובין מסוכרר פחות מ-8.5%

74. בן 75, ברקע מחלת לב איסכמית, אירוע לבבי לפני כ- 5 שנים, מטופל ב- ASPIRIN. התקבל לאשפוז בעקבות דלקת ריאות. במהלך האשפוז בעקבות פרפור פרוזדורים עם הולכה חדרית של 120 לדקה טופל בחוסמי ביטא וחזר לקצב סינוס. המטופל במשקל 70 ק"ג, בד"כ נייד בבית, נפל לפני כחצי שנה בביתו בעקבות התקלות בשטיח, תפקודי כליה תקינים. מהו הטיפול התרופתי המומלץ בשחרורו?

א. הוספת טיפול ב- APIXABAN 2.5mg פעמיים ביום
ב. הפסקת טיפול ב- ASPIRIN התחלת טיפול ב- APIXABAN 5mg פעמיים ביום
ג. הוספת טיפול ב- RIVAROXABAN 15mg פעם ביום.
ד. המשך טיפול ב- ASPIRIN בלבד

75. במטופל עם פצע לחץ ללא חסרים תזונתיים, איזה תוסף תזונתי נמצא כמסייע לרפוי פצע אם ניתן לפחות 4 שבועות?

א. ויטמין A

ב. ויטמין C

ג. ברזל

ד. אבץ

76. מה מאפיין שינויים פתופיזיולוגים במצב של Frailty?

א. מאזן אנרגיה (Energy Balance) חיובי

ב. ירידה ב- Resting Metabolic Rate

ג. הארכה של טלומרים

ד. עליה בפעילות הורמונים אנאבולים

77. בן 80, מתגורר בביתו. מתאשפז בחורף במחלקה פנימית לבירור קוצר נשימה, שיעול וירידה בסטורציה. ברקע: COPD בדרגת חומרה קלה-בינונית. ללא אשפוז או טיפול אנטיביוטי בשנה האחרונה.

מה הצעד האבחנתי המומלץ בשלב זה?

א. דגימת כיח לתרבית לצורך התאמת טיפול אנטיביוטי מכוון

ב. מטוש אנטיגן לשפעת עונתית להחלטה על טיפול אנטי-ויראלי

ג. PCR ל Rhinovirus. במידה וחיובי – הימנעות מטיפול אנטיביוטי

ד. דגימת דם לרמת פרוקלציטונין להחלטה על צורך בטיפול אנטיביוטי

78. בת 72 אושפזה לבירור ירידה במשקל. היא מדווחת על קושי בבליעה ובלעיסה ועקב זה הפסיקה לאכול בשר. בתשובה לשאלה מכוונה מדווחת על דיפלופיה.

מה השלב הבא בבירור?

א. PET-CT

ב. EEG

ג. בדיקת נוגדנים Anti-Acetylcholine Receptor

ד. בדיקת נוגדנים Anti-NMDA Receptor

79. בן 84 הגיע ליעוץ גריאטרי עקב ירידה קוגניטיבית שהחמירה בחודש האחרון. כמו כן מתלונן על תופעות חדשות של עצירות, טשטוש ראיה ויובש בפה. מדווח שהיה לפני חודש במרפאת כאב והחל תרופה חדשה במינון נמוך.

איזו תרופה חדשה שקיבל יכולה להסביר את התסמינים שלו?

א. AMITRIPTYLINE (ELATROL)

ב. VENLAFAXINE (VIEPAX)

ג. DULOXETINE (CYMBALTA)

ד. GABAPENTIN

80. בן 88, ערירי. מאושפז כחודש במחלקה פנימית בשל זיהום בקורונה שהסתבך. טרם האשפוז גר בביתו בגפו, נעזר במטפלת מטעם חוק סיעוד (עזרה ב-IADL וברחצה).

כעת מועמד לשחרור, אחרי גמילה מהנשמה, עם פצעי לחץ דרגה 3 בסקרום ובטרוכנטר. זקוק לעזרה מלאה בכל התפקודים כולל האכלה, אינו שולט על סוגר השתן, נעזר באמצעי ספיגה.

עירני, מבצע הוראות פשוטות, קם בעזרה של 2 מטפלים והולך עם הליכון אמות 3 מטרים בעזרה רבה.

כיצד יש להגדיר את הסטטוס של המטופל ולאן יש להפנותו?

א. סיעודי מורכב, למחלקת לסיעוד מורכב

ב. סיעודי זמני, לנופשון במחלקה סיעודית

ג. שיקומי, למחלקת שיקום

ד. שיקומי, לשיקום בית

81. בת 85 גרה במחלקה סיעודית, מרותקת לכיסא גלגלים וסובלת מדמנציה קשה. בשנתיים האחרונות היא לא שולטת על שני הסוגרים ונעזרת בחיתול 24 שעות. אחת לשנה לוקחים לחולה בדיקות שגרתיות כולל ספירה, כימיה ושתן לכללית. הספירה והכימיה תקינות. בבדיקת שתן לכללית נמצאו לויקוציטים רבים ללא אריתרוציטים. החולה מרגישה טוב, ללא חום ולא נראית סובלת. מה ההמלצה לצוות המטפל?

א. נטילת תרבית שתן. אם תהיה צמיחה התחלת טיפול אנטיביוטי על פי רגישות

ב. נטילת תרבית שתן. התחלת טיפול אנטיביוטי אמפירי עד קבלת תשובות התרבית

ג. התחלת טיפול אנטיביוטי אמפירי ללא תרבית

ד. מעקב בלבד

82. למי מחולי הפרקינסון הבאים מומלץ טיפול Deep Brain Stimulation?

א. מטופל עם רעד בלתי נשלט

ב. מטופל עם נפילות

ג. מטופל עם דיכאון ומחשבות אובדנות

ד. מטופל עם דמנציה

83. בן 75, עם הפרעה בתפיסה מרחבית ובתפקודים ניהוליים מזה שנה, מינימנטל 18 בבדיקה לפני 3 חודשים וכעת מינימנטל 25. זקוק לעזרה בניהול התרופות וכספיו בחצי שנה האחרונה. סובל מהזיות ראייה ותנועות מרובות מתוך שינה. מתוארים שינויים ניכרים במצבו במהלך היום. בבדיקה ניכרת ריגידיות, ברדיקינזיה ואורטוסטטיזם. שיפור משמעותי בתסמיניו עם טיפול ב- DONEPAZIL במינון 10 מ"ג. סבל מהחמרה מוטורית קשה קשה בניסיון טיפולי עם QUANTAPINE (SEROQUEL) במינון 25 מ"ג.

מהי האבחנה הסבירה ביותר?

א. Possible Dementia With Lewy Bodies - ייתכן שמדובר בדמנציה מסוג Lewy Body אבל אינו ממלא מספיק קריטריונים

ב. Probable Dementia With Lewy Bodies - ככל הנראה מדובר בלואי בודי דמנציה

ג. Probable Parkinson's Disease Dementia - סביר שמדובר בדמנציה של פרקינסון מכיוון שחלפה שנה מהתחלת תסמיניו הקוגניטיבים

ד. Possible Parkinson's Disease Dementia - ייתכן שמדובר בדמנציה של פרקינסון לאור הופעת ההזיות בתחילת המחלה

84. איזו מההצהרות הבאות נכונה לגבי המלצות הקריטריונים של BEERS לגבי נוגדי קרישה עבור קשישים?

א. ל- WARFARIN יש יעילות דומה ל-DOAC בטיפול ב-VTE או בפרפור פרוזדורים לא-שסתומי (Non-Valvular), וגם סיכון דומה לדימום מג'ורי

ב. DABIGATRAN הוא נוגד קרישה בטוח ויעיל יותר מ-APIXABAN עבור קשישים

ג. יש להימנע משימוש ב-APIXABAN עבור מטופלים עם מחלת כליות סופנית

ד. WARFARIN אינו מומלץ כטיפול התחלתי עבור VTE או פרפור פרוזדורים לא-שסתומי (Non - Valvular), אלא אם כן אין חלופות מתאימות

85. בת 89 סובלת מסרטן ריאות גרורתי, תוחלת חיים משוערת של מספר חודשים. מטופלת בהוספיס בית. מה הגישה הנכונה לאיזון סוכרת במצבה?

א. עדיפות לשימוש במעכבי SGLT2 להשגת המוגלובין A1C 7-7.5%

ב. הפסקת טיפול תרופתי לסוכרת והפסקת מעקב בדיקות דם

ג. שחרור ההגבלות התזונתיות

ד. איזון סוכר בצום בערכים בין 100 ל- 130

86. מה מאפיין סרטן של המעי הגס COLON CANCER בקשישים לעומת צעירים?

א. בקשישים הסיכוי לאבחון ממאירות בשלב מתקדם וגרורתי גבוהה יותר

ב. התמותה הפרי-ניתוחית בקשישים דומה לזו שבצעירים

ג. התסמינים הקשורים לממאירות בקשישים ובצעירים זהים כולל ירידה במשקל

ד. בקשישים יש יותר גידולים בצד הימני של המעי עם סיכון לפרפורציה

87. איזו המלצה נכונה למניעה של Catheter Associated Urinary Tract Infection במטופל עם שלפוחית נוירוגנית משנית לפראפלגיה?

א. מתן טיפול אנטיביוטי מונע

ב. לקיחת תרבית שתן שגרתית אחת לחודש ומתן טיפול לפי הצורך

ג. ביצוע צנתור לסירוגין Intermittent Catheterization

ד. החלפת צנתר שלפוחית שתן לפחות אחת לחודש

88. מה נכון לגבי פיזיולוגיה נורמלית של שלפוחית השתן?

א. נפח ממוצע של שלפוחית שתן הוא 600-800 סמ"ק

ב. דחף למתן שתן מתחיל במילוי שלפוחית של 400 סמ"ק

ג. משך ממוצע של מתן שתן הוא 2-4 דקות

ד. ערך תקין של שארית לאחר מתן שתן (Post Void Residual) PVR הוא פחות מ- 100 סמ"ק

89. בן 82, עצמאי בתפקודו, עבר בירור עקב חולשה ונמצאה רמת טסטוסטרון נמוכה. המטופל מעוניין בטיפול תרופתי בטסטוסטרון.

מה מהבאים מהווה קונטראינדיקציה לטיפול בטסטוסטרון?

א. אנמיה

ב. סרטן ערמונית גרורתי

ג. דיכאון

ד. אוסטאופורוזיס

90. בן 78, עם סרטן ערמונית מתקדם גרורתי, הוגדר כסופני (בשבועיים האחרונים לחייו). סוכם עם בני משפחתו על טיפול תומך בלבד. באשפוז נכנס לדליריום היפראקטיבי עם סימני אי-שקט פסיכומוטורי. טיפול ב- HALOPERIDOL לא עזר.

מה הגישה לגבי טיפול בבנזודאזפינים במצב זה?

א. יש להימנע מטיפול בבנזודאזפינים מאחר שמחמירים דליריום

ב. מומלץ שימוש בתרופות מסוג בנזודאזפינים ארוכי טווח כגון DIAZEPAM

ג. יש להימנע ככל הניתן ממתן בזריקות ולהתמקד במתן פומי

ד. מומלץ טיפול בבנזודיאזפינים קצרי טווח כגון MIDAZOLAM עם אפשרות טיטרציה

91. בן 78, מטופל כרונית לתסמיני היפרטרופיה של פרוסטטה (BPH) וליתר לחץ דם מאוזן, מתעניין במתן ייפוי כוח לבנו. מה מהבאים נכון בנוגע לאפשרויות העומדות בפניו?

א. לחתום על ייפוי כוח רפואי על ידי רופא ועובדת סוציאלית

ב. לחתום על ייפוי כוח מתמשך מלא (רפואי ורכוש) על ידי גריאטר מומחה

ג. לחתום על ייפוי כוח לרכוש על ידי פקיד בכיר בבנק

ד. לחתום על ייפוי כוח רפואי על ידי אחות מומחית קלינית בגריאטריה

92. בת 73, מגיעה למיון עם קוצר נשימה, החמרה במצבה בחודש האחרון, ירידה תפקודית, וסחרחורת במאמץ מינימאלי מזה כשבוע. אשפוזים חוזרים בחצי שנה האחרונה עקב החמרת אי ספיקת לב. רקע:

- מחלת לב איסכמית – ניתוח מעקפים לפני כ- 10 שנים, צנתור אחרון במהלך אשפוזה הקודם עם התערבות למעקפים ופתיחתם
- מחלת כלי דם היקפיים
- סוכרת

מטופלת במשתנים במינונים מקסימאליים, SACUBITRIL/VALSARTAN (ENTRESTO) במינון מקסימאלי וב- SGLT2.

בבדיקה - לחץ דם 125/80, דופק 105, נשימות 24.

מעבדה - BUN 23, קריאטינין 1.5 בהחמרה מבסיס.

אק"ג - סינוס טכיקרדיה ללא הפרעת הולכה.

אקוקרדיוגרפיה - חדר שמאל מורחב עם מקטע פליטה 20%, ואי ספיקה מיטראלית קלה.

מה מהבאים יכול לשפר את איכות חייה ויאריך אותם?

א. השתלת קוצב – Cardiac resynchronization therapy (CRT)
ב. מכשיר תומך בחדר שמאל - Left ventricular assisted device (LVAD)
ג. תיקון מסתם מיטראלי – Mitral Clip
ד. אין מה שיכול לשפר את מצבה, מומלץ להעבירה לטיפול פליאטיבי בלבד.

93. בן 83 סובל מהידרדרות תפקודית וקוגניטיבית בשנה האחרונה. הוא הולך לאט מאוד, סובל מנפילות חוזרות, סובל מפחד מפני נפילות, ירד במשקל 7 ק"ג בשנה האחרונה, מרגיש עייפות כל הזמן, וגם עולה חשד למחלת אלצהיימר בחומרה בינונית. לפי הקריטריונים של FRIED כיצד ניתן להגדיר את החולה?

א. PREFRAIL
ב. FRAIL
ג. VERY FRAIL
ד. COGNITIVE FRAIL

94. בת 84 מטופלת במחלקה שיקומית לאחר שבר בצוואר הירך. לאחר חודש של שיקום היא הולכת עם הליכון בהשגחה בלבד בתחום החדר ומתוכננת להשתחרר למחלקה סיעודית.
מה תפקיד הריפוי בעיסוק בשיקום שלה?

א. שליחת צוות לביקור לבדיקת התאמת המסגרת לתפקודה
ב. הערכה קוגניטיבית בשאלה של התאמתה למחלקה לתשושי נפש
ג. שיפור ADL – אכילה, הלבשת פלג גוף עליון, טיפוח
ד. במצב זה אין תועלת בריפוי בעיסוק

95. מה מהבאים מהווה גורם לאוסטיאופורוזיס שניוני?

א. היפרתירואידיזם
ב. מין – אישה
ג. קורס של 5 ימים של PREDNISONE 30 mg
ד. סוכרת שאינה תלויה באינסולין

96. בן 73, עם ציון מינימנטל של 23, איזה מהבאים מחשיד לדמנציה **אחרת שאיננה אלצהיימר** ?

א. ירידה של 3 נקודות במינימנטל בשנה
ב. המטופל לא מסוגל לכתוב הודעות בטלפון הנייד בשנה האחרונה
ג. הפרעות בשנת ה- REM
ד. קושי בשליפת מילים

השאלות הבאות הן שאלות שלילה.

97. מה מהבאים **לא** מוכר כסיבוך של האכלת צינור?
   א. עצירות
   ב. תמותה
   ג. דלקת ריאות
   ד. ירידה במשקל

98. מה **לא** גורם הפיך לאי שליטה על סוגר השתן?
   א. מחלת עורקים פריפרית (PVD)
   ב. וגיניטיס אטרופית (Vaginitis Atrophic)
   ג. היפרקלצמיה
   ד. אי ספיקת לב עם בצקת פריפרית

99. איזה מהבאים **לא** מעלה סיכון ל- Deep Vein Thrombosis?
   א. טיפול ב- TAMOXIFEN
   ב. תסמונת נפרוטית
   ג. סרטן לבלב
   ד. טיפול תרופתי ב- (CIPRALEX) ESCITALOPRAM

100. בן 75 אחרי שבר בצוואר הירך עם כאב נוירופטי ומצב רוח ירוד. ברקע מטופל ב- (KEPRRA) LEVETIRACETAM על רקע מחלה פרכוסית. סובל מזיהום בפצע הניתוחי.
איזה מהתרופות הבאות **לא** תעלה את הסיכון לפרכוסים?
   א. (TRAMADEX) TRAMADOL
   ב. (CIPRO) CIPROFLOXACIN
   ג. (WELLBUTRIN) BUPROPION
   ד. (LYRICA) PREGABALIN

101. לבן 85 נמצא המוגלובין 18.5. מה יכולה להיות סיבה לעליה בהמוגלובין?

א. Renal Failure

ב. Renal Artery Stenosis

ג. Ischemic Heart Disease

ד. Acute Erythroid Leukemia

102. בת 75, התקבלה לבירור חום ממושך וכאבי גב תחתון. יציבה המודינמית, חום 38.5 מעלות צלזיוס ללא רקע של ניתוחי עמוד שדרה או בדיקות פולשניות לאחרונה. בבדיקת MRI חשד ל- Vertebral Osteomyelitis.

מה השלב הבא בניהול המקרה?

א. ניתן להמתין עד קבלת תשובות תרבית לפני התחלת טיפול

ב. התחלת טיפול אמפירי ב- VANCOMYCIN + LEVOFLOXACIN

ג. הפניה לביצוע EMG לשלילת פגיעה אקסונלית

ד. ביצוע ניקור מותני (LP) לשלילת מעורבות נוזל חוט שדרה

103. בן 75, עם רקע של יתר לחץ דם ויתר שומני הדם, מתקבל למיון עם תפיחות חדשה בבטן.

בבדיקה גופנית חשד למיימת.

בוצע ניקור אבחנתי עם התוצאות הבאות:

Blood Total Protein – 6 g/dL

Blood Albumin - 3.5 g/dL

Ascites Protein – 3 g/dL

Ascites Albumin – 2 g/dL

איזה מהמצבים הבאים מתאים לתוצאות הבדיקה?

א. תסמונת נפרוטית

ב. צירוזיס

ג. אי ספיקת לב

ד. פנקראטיטיס

104. בת 79, אובחנה עם פרפור עליות והחלה טיפול ב- AMIODARONE. לאחר מספר שבועות החלו תלונות על עייפות, חולשה, תחושת קור, עצירות ועליה במשקל. מה ההמלצה לשלב הבירור הבא?

א. בדיקת רמת Thyroid-Stimulating Hormone (TSH)

ב. בדיקת רמת Thyroid-Binding Globulin (TBG)

ג. מפוי לבלוטת התריס

ד. אולטרסאונד לבלוטת התריס

105. מה מהבאים נכון בנוגע לכאב ראש פוסט-טראומטי?

א. כאב הראש יכול להמשך שנים לאחר האירוע

ב. אבחנה מתבצעת לרוב על ידי MRI

ג. בבדיקה נוירולוגית תהיה עדות לסימני צד

ד. אירוע זיהומי לא מהווה סיבה לכאב ראש זה

106. בן 82 מגיע למיון בעקבות בלבול חריף ועצירות. בבדיקות מעבדה:

מדד ויחידות מידה	ערך לחולה	ערכי הנורמה
Creatinine mg/dL	2.1	0.67-1.17
Ca mg/dL	12.5	8.5-10.5

באק"ג: סינוס 76 פעימות בדקה, QT מקוצר.

מה הטיפול הראשוני המומלץ?

א. דיאליזה

ב. טיפול ב -FUROSEMIDE

ג. טיפול תוך ורידי ב- SALINE 0.9%

ד. ZOLENDRONIC ACID

107. מה נכון בנוגע לפגיעה באברי מטרה בסוכרת מסוג 2?

א. נפרופתיה סוכרתית היא הסיבוך המיקרו-וסקולרי השכיח ביותר

ב. נפרופתיה סוכרתית לא קשורה לסיכון להתפתחות מחלה קרדיווסקולרית

ג. נוירופתיה סוכרתית מתפתחת לפני אבחון הסוכרת

ד. נוירופתיה סוכרתית יכולה להתבטא בראיה כפולה ופטוזיס

108. גבר בן 75 מגיע למיון עם כאבים בחזה. בתרשים האק"ג – **תמונה מספר 5.**
אילו מהמצבים הבאים יכול לגרום לממצאים באק"ג?

א. Hypokalemia
ב. Hypercalcemia
ג. Hypomagnesemia
ד. Hypernatremia

109. בת 72, ברקע סכיזופרניה ללא מעקב רפואי. מאושפזת לאחר נפילה ושבר בצוואר הירך.
בבדיקה הגופנית ציאנוזיס של האצבעות ו- Clubbing.
מה מהאבחנות הבאות עשויה להיות מתאימה?

א. Emphysema
ב. Raynaud's Phenomenon
ג. Deep Vein Thrombosis
ד. Peripheral Vascular Disease

110. בן 70 אושפז לבירור נפיחות בברך. שבועיים טרם בדיקתו עבר ניתוח לכריתת בלוטת יותרת התריס (Parathyroidectomy). בנוסף, ידוע על נפילות חוזרות.
אילו מהעובדות הבאות תומכת באבחנה של Acute Calcium Pyrophosphate Arthritis (Pseudogout) כסבירה יותר מאשר אבחנה של Gout?

א. היפוקלצמיה חריפה
ב. אירוע קודם של טראומה בברך
ג. אודם מקומי מעל הברך
ד. רמת חומצה אורית (Uric Acid) תקינה בדם

111. מה מאפיין ממצאי מעבדה של אנמיה של מחלה כרונית?

א. MCV גבוה
ב. אחוז רטיקולוציטים גבוה
ג. FERRITN נמוך
ד. TRANSFERIN נמוך

112. בת 80, לאחר כריתה שלמה של בלוטת התריס בשל ממאירות, מובאת לחדר מיון בשל עייפות, חולשה ושקיעה במצב ההכרה בימים האחרונים.

בבדיקה: שקועה עם תגובה לכאב אך לא לקול, חום רקטלי 33 מעלות צלזיוס.

במעבדה:

מדד ויחידות מידה	ערך לחולה	ערכי הנורמה
Na mEq/L	127	135-145
Glucose mg/dL	75	72-100
CPK U/L	400	55-170

מה הטיפול הראשון שיש לתת במצב המתואר?

א. SALINE 3%

ב. SALINE 0.9% מחומם

ג. LIOTHYRONINE

ד. HYDROCORTISONE

113. בן 80, עם שחמת כבד מתקדמת על רקע הפטיטיס C וניקורים חוזרים עקב מיימת. מטופל ב-SPIRONOLACTONE ו- FUROSEMIDE ולמרות זאת עדיין סובל מאשפוזים חוזרים עקב מיימת. תוספת של איזה מהטיפולים הבאים יכול לעזור למיימת הרפרקטורית?

א. CARVEDILOL (DIMITONE)

ב. DOXAZOSIN (CADEX)

ג. CLONIDINE (NORMOPRESSAN)

ד. HYDRALAZINE

114. מה הטיפול האמפירי הראשוני בחשד למנינגיטיס?

א. FLUCONAZOLE+ CEFEPIME + GENTAMYCIN + GANCYCLOVIR

ב. DEXAMETHASONE + CEFTRIAXONE + VANCOMYCIN

ג. DEXAMETHASONE + CEFTRIAXONE + VANCOMYCIN + ACYCLOVIR

ד. RIFAMPIN + AMPICIILINE + VANCOMYCIN + GANCYCLOVIR + METRONIDAZOLE

115. בן 75, הגיע למרפאה לבירור עקב שתן קצפי ובצקות. בבדיקה: בצקת פריפרית, אלבומין 2.5 gr/dL (ערכי נורמה 3.5-5.2) ואיסוף חלבון ל- 24 שעות של 4 gr ליממה (ערכי נורמה 0-150 mg).
איזה מהמצבים הבאים יכול לגרום לתסמונת ממנה סובל המטופל?

א. Amyloidosis
ב. Postinfectious Glomerulonephritis
ג. anti-GBM disease
ד. ANCA vasculitis

116. בן 80 מגיע למיון עם קוצר נשימה. בתרשים האק"ג – **תמונה מספר 6.**
בעקבות האק"ג בוצע אקו לב. מה מהבאים אופייני למצוא בבדיקת האקו אצל מטופלים עם האק"ג שבתמונה?

א. היפרטרופיה של חדר שמאל
ב. תפליט פריקרדיאלי
ג. AORTIC STENOSIS
ד. MITRAL REGURGITATION

117. בן 68, עם רקע של סוכרת לא מאוזנת, אי ספיקת לב מתקדמת, אי ספיקת כליות (קריאטינין 1.8), יתר לחץ דם ועישון כבד. אובחן לפני מספר שבועות עם אדנוקרצינומה ריאתית גרורתית לכבד.
ידוע על שחמת במגמת החמרה עם אירוע של דימום מדליות בושט והתפתחות מיימת.
איזה מהבאים מהווה התוויה לטיפול אנטיביוטי מניעתי ל- Spontaneous Bacterial Peritonitis (SBP)?

א. אבחנה של ממאירות סולידית
ב. היסטוריה של דימום מדליות בושט
ג. סוכרת לא מאוזנת
ד. אבחנה של תסמונת הפטורנלית (Hepato-Renal Syndrome)

118. איזו מבין התרופות הבאות מורידה הפרשה של TSH?

א. LITHIUM
ב. PREDNISONE
ג. SERTRALINE
ד. TAMOXIFEN

119. בת 75 אובחנה עם Idiopathic Pulmonary Fibrosis. הומלץ להתחיל טיפול תרופתי בתכשירים אנטי-פיברוטיים. מה נכון לגבי תרופות אלה?

א. תופעות לוואי גסטרואינטסטינליות כוללות שלשול ובחילה

ב. רוב תופעות הלוואי הן מינוריות ולא מצריכות הפסקה של הטיפול

ג. התרופות עוצרות את התקדמות המחלה

ד. התרופות פועלות על מנת לתקן את הנזק שנגרם לריאות

120. בן 80 ביצע בדיקת דם שגרתית ונמצאו בה 2500 לויקוציטים 1100 נויטרופילים. מה יכולה להיות התרופה שגרמה לכך?

א. LITHIUM

ב. CARBAMAZEPINE (TEGRETOL)

ג. FILGASTIM (G-CSF)

ד. PREDNISONE

121. בת 70, עם רקע של סכיזופרניה, מגיעה למיון עם ירידה במצב הכרה, בלבול וכאבי ראש.
בבדיקתה: ללא בצקות, ללא רושם לסימני התייבשות.
בבדיקות מעבדה היפונתרמיה של 122 mEq/L.
בבדיקת השתן אוסמולארית של 100 mOsm/kg. ריכוז הנתרן בשתן 10 mM.
איזה מהמצבים הבאים יכול להסביר את ההיפונתרמיה?

א. פולידיפסיה

ב. היפותירואידיזם

ג. טיפול בתיאזיד

ד. גידול ריאתי

122. איזה מהבאים היא אינדיקציה לטיפול בכריתת בלוטת יותרת התריס (Parathyroidectomy) באנשים מבוגרים עם היפרפאראתירואידיזם ראשוני?

א. צפיפות עצם עם T- Score פחות ממינוס 1

ב. Calcium Score גבוה ב- CT קורונרים

ג. איסוף שתן לסידן מעל 400 מ"ג ל- 24 שעות

ד. סימני Chvostek Sign ו- Trousseau Sign

123. איזה מהבאים נמצא יעיל במניעת זיהומים הקשורים לצנתרים ורידיים במאושפזים?

א. להחליף עירויים פריפריים כל 24 שעות

ב. להימנע ככל הניתן משימוש בצנתרים ג׳וגולריים ולהעדיף צנתרים פמורליים

ג. לתת אנטיביוטיקה מניעתית לפני החדרת צנתר מרכזי

ד. לבצע רחצה יומית של חולים בטיפול נמרץ /מוגבר ב- CHLOROHEXIDINE

124. באיזה מהמצבים הבאים של פגיעה כלייתית עם עלית קריאטינין יש סיכוי גבוה להחלמה מלאה אחרי שבוע?

א. Tumor Lysis

ב. Multiple Myeloma

ג. Contrast Nephropathy

ד. Tubular Injury from Vancomycin

125. בן 75, ללא מחלות רקע. מתאשפז בגלל דמם רקטלי שהחל ביום פנייתו.

בבדיקה: חיוור, ל"ד 80/40, דופק 110 לדקה, סטורציה 97% באוויר חדר, בטן רכה ללא רגישות במישוש. בבדיקה רקטלית דם טרי.

במעבדה: המוגלובין 7 gr/dL (לפני חודש המוגלובין 12 gr/dL).

החולה מטופל בנוזלים ומנת דם, ולחץ הדם עולה ל- 110/70.

איזו בדיקה יש לבצע כעת?

א. קולונוסקופיה

ב. גסטרוסקופיה

ג. CT אנגיו של הבטן

ד. מיפוי כדוריות אדומות

126. איזו מהפרעות הקרישה הבאות גורמות לסיכון מוגבר ל- DEEP VEIN THROMBOSIS?

א. Vov Wilebrand Disease

ב. חוסר ב- Factor XI

ג. חוסר ב- Anti Thrombin III

ד. Bernard Soulier Syndrome

127. בן 80 מגיע למחלקה לרפואה דחופה עם חום גבוה.
איזה מהמדדים הבאים קשור בסיכון גבוה לתמותה לפי אומדן SOFA?

א. Glasgow Coma Scale = 15
ב. (MAP) Mean Arterial Pressure > 70 mmHg
ג. Creatinine = 1.7 mg/dL
ד. Platlets = 170 x 10^3 /µL

128. לאיזו מהתרופות הבאות לטיפול בבצקת ריאות יש גם אפקט לשיפור כושר ההתכווצות של הלב (CONTRACTILITY) ?

א. NITROGLYCERIN
ב. FUROSAMIDE
ג. ENALAPRIL
ד. MILIRONE

129. בן 78, יומיים לאחר ST-Elevation Myocardial Infarction (STEMI) ומאושפז בטיפול נמרץ לב. ביום השני הופיעה סינוס ברדיקרדיה חדשה עם קצב של 55 לדקה, אך המטופל יציב המודינמית ונשימתית.
מה מהבאים הוא הטיפול המתאים לברדיקרדיה זו לאחר STEMI?

א. טיפול ב- ISOPROTERENOL במינון של 1 מק"ג לדקה
ב. טיפול ב- ATROPINE במינון 0.5 מ"ג
ג. הכנסה מיידית של קוצב לב
ד. השגחה בלבד, ללא צורך בהתערבות נוספת

130. איזה מהבאים מאפיין תוצאות ניקור של מפרק עם Nongonococcal Bacterial Arthritis?

א. רמות גלוקוז גבוהות
ב. תרבית חיובית במרבית המקרים
ג. ספירת תאים לבנים 10-20,000/µL
ד. רמות LDH נמוכות

131. בת 74, התקבלה למיון עם חולשה לאחר מחלת חום. בבדיקת גזים בדם בחדר המיון הממצאים הבאים:

מדד ויחידות מידה	ערך לחולה	ערכי הנורמה
PH	7.26	7.37-7.44
PCO2 mmHg	32	40-51
PO2 mmHg	88	65-105
HCO3 mmol/L	18	22-26
Na mEq/L	140	135-145
Cl mEq/L	112	96-106
K mM/L	5.6	3.5-5

מהי האבחנה המתאימה?

א. טיפול ב- AMPHOTERICIN B

ב. Renal Tubular Acidosis Type 4

ג. Hyperaldosteronism

ד. הרעלת אתילן גליקול

132. בן 61 מתקבל למיון בשל מספר אירועים של כאבים בחזה ביום קבלתו, מדדים חיוניים תקינים. אק"ג במיון מראה עליות ST בקיר קדמי. זמן קצר לאחר הגעתו הוא מפתח שני אירועים של SHORT VT, כל אחד מהם נמשך כחמש שניות וחולף ספונטנית. מדדים תקינים וללא תלונות כעת מצד החולה. כיצד יש לטפל בו?

א. מתן IV AMIODARONE במינון 150 מ״ג תוך 10 דקות

ב. מתן LIDOCAINE במינון 100 מ״ג ב- IV PUSH

ג. סדציה והיפוך חשמלי מסונכרן

ד. צנתור דחוף

133. בת 75, עם ממצא של אנמיה והיפרקלצמיה, עברה בדיקות דם בשאלה של MULTIPLE MYELOMA.

בבדיקות:

מדד ויחידות מידה	ערך לחולה	ערכי הנורמה
Total Protein gr/dL	5.4	6.7-8.6
Albumin gr/dL	3.9	3.5-5.2

אלקטרופורזה של חלבונים ללא פיק מונוקלונלי.

מה השלב הבא בברור?

א. בדיקת דם לשרשראות קלות

ב. איסוף שתן לחלבון כמותי

ג. בדיקת דם לאימונוגלובולינים כמותי

ד. היות ונשללה מיילומה יש להמשיך בירור בכיוון מחלות אחרות

134. מהו הטיפול האנטיביוטי מניעתי לאנדוקרדיטיס, המתאים למטופל עם כותרת של אלרגיה ל-AMOXICILLIN/ CLAVULANIC ACID (AUGMENTIN)?

א. VANCOMYCIN במינון 750 מ"ג

ב. CLINDAMYCIN במינון 600 מ"ג

ג. AZITHROMYCIN במינון 500 מ"ג

ד. CIPROFLOXACIN במינון 500 גרם

135. בן 68 עם ST-ELEVATION MI (STEMI) יציב המודינמית ובמוניטור הופעה של פעימות מוקדמות ממקור חדרי.

איזו תרופה מומלצת כטיפול מונע להפרעות הקצב החדריות?

א. BETA-BLOCKERS

ב. AMIODARONE

ג. VERAPAMIL

ד. LIDOCAINE

136. בן 77 פנה למחלקה לרפואה דחופה עקב חום וכאבים עזים בכף הרגל, ללא חבלה. בבדיקות המעבדה – תפקודי כליה ואלקטרוליטים תקינים, לויקוציטים 12,300, המוגלובין וטסיות תקינים.
מצורפת תמונה של כפות הרגליים, **תמונה מספר 7.**
מה השלב הבא בטיפול בחולה?

א. התחלת טיפול אנטיביוטי ב- CEFAMEZIN
ב. הפניה לצילום רנטגן
ג. התחלת טיפול ב- COLCHICINE
ד. ניקור של המפרק

137. בן 68 מתקבל למחלקה לרפואה דחופה במצב כללי ירוד, לחץ דם 95/50. במעבר מהאלונקה למיטת בית החולים דיווח על סחרחורת ותחושת פרה-עילפון. בבדיקתו אין גודש ורידי צוואר, הגפיים קרות למגע.
מה השלב הבא בטיפול?

א. טיפול אנטיביוטי אמפירי באבחנת שוק ספטי
ב. צנתור דחוף באבחנת שוק קרדיוגני
ג. מתן נוזלים באבחנת שוק היפוולמי
ד. מתן דם באבחנת שוק היפוולמי

138. מה מאפיין את החמצת המטבולית במטופל עם Chronic Renal Failure?

א. מופיעה בשלבים מאוחרים של המחלה
ב. בדרך כלל מאוד קשה
ג. אפשר לתקן אותה עם SODIUM BICARBONATE
ד. בדרך כלל חמצת מסוג High Anion Gap

139. מה מהבאים נכון לגבי אבחון אנצפליטיס וירלית?

א. אם IgM חיובי לקדחת הנילוס המערבי בדם אין צורך בבדיקת הווירוס ב- CSF
ב. בדיקת MRI מוח תדגים נגעים באונות טמפורליות במיעוט המקרים של אנצפליטיס מ- HSV1
ג. בחשד לאנצפליטיס על רקע וריצלה זוסטר מספיקה בדיקת PCR
ד. בדיקת PCR ל- HSV1 עשויה להיות שלילית ב- 72 השעות הראשונות

140. איזה ממצא בבדיקה גופנית אופייני ל- MITRAL VALAVE PROLAPSE (MVP) בניגוד ל- MITRAL REGURGITATION (MR) פונקציונלי?

א. החלשות האוושה כשהחולה על צד שמאל

ב. התגברות האוושה ברכינה קדימה

ג. התגברות האוושה בזמן ולסלבה

ד. החלשות האוושה כשהחולה בעמידה

141. בן 75 פונה למרפאה בשל כאבי ראש חדשים ורגישות במישוש הרקה השמאלית. מה מהבאים נכון?

א. במידה וביופסיה מעורק טמפורלי שלילית, יש להמשיך בירור אודות סיבה אחרת לכאבים

ב. יש סכנה משמעותית לפגיעה בראיה ולכן חשוב להתחיל טיפול בסטרואידים מיד לאחר הביופסיה

ג. הטיפול הוא סטרואידים במינון גבוה, ובשל תופעות לוואי שלהם יש להקפיד על הפחתה מהירה יחסית במינון

ד. במטופלים עם סיכון משמעותי לתופעות לוואי של סטרואידים, מומלץ לשלב בתחילת הטיפול תכשיר TOCILIZUMAB (ACTEMRA)

142. בת 95 עם ממצא מקרי של פרפור עליות. נשקלת האפשרות לטיפול בנוגד קרישה. איזה מהבאים מהווה רכיב ב- HAS-BLED Score?

א. אי ספיקת לב

ב. דיברטיקולוזיס

ג. יתר לחץ דם

ד. עבר של חבלת ראש

143. בן 81 הופנה למיון לאחר שנמצא בביתו בהכרה מעורפלת. מהאנמנזה עולה כי בשבועות האחרונים התלונן על שיעול וחלה ירידה באכילה ובשתייה. ברקע: סוכרת המטופלת ב- METFORMIN ו -INSULIN ויתר לחץ דם המטופל ב- HYDROCHLOROTHIAZIDE . לא ידוע מעברו על פגיעה כלייתית.

בבדיקתו: סימני התייבשות, דופק 113, לחץ דם 80/40, 26 נשימות לדקה, חום 37.6 מעלות, משקלו 80 ק"ג.

בבדיקות הדם:

מדד ויחידות מידה	ערך לחולה	ערכי הנורמה
Creatinine mg/dL	2.5	0.67-1.17
Glucose mg/dL	250	72-100
Na mEq/L	160	135-145
K mM/L	3.5	3.5-5
Urea mg/dL	210	7-20
Osmolarity mOsm/L	408	285-295

בצילום חזה : תסנין בבסיס ריאה שמאל

בנוסף לטיפול אנטיביוטי בשל אבחנה של דלקת ריאות, איזה מבין הטיפולים ההתחלתיים הבאים הוא המומלץ ביותר למצב הנוכחי?

א. 1 ליטר תמיסת 0.45% Sodium Chloride

ב. 1 ליטר תמיסת 0.9% Sodium Chloride

ג. 1 ליטר תמיסת 0.45% Sodium Chloride למשך שעה, בתוספת אינסולין תוך ורידי בקצב של 4 יחידות לשעה

ד. 1 ליטר תמיסת 0.9% Sodium Chloride למשך שעה, בתוספת אינסולין תוך ורידי בקצב של 4 יחידות לשעה

144. בן 75, מאושפז בשיקום לאחר שבר בירך. ברקע ידוע על אי ספיקת לב עם מקטע פליטה של 30% (LVEF), יתר לחץ דם ופרפור עליות שמטופל בחסמי בטא וב- APIXABAN (ELIQUIS) במינון 5 מ"ג פעמיים ביום. ביום השני לאשפוזו נצפתה יציאה דמית גדולה. בבדיקתו חיוור, לחץ דם 80/40, דופק 95, ריווי חמצן וחום תקינים. בבדיקות דם ירידת המוגלובין מבסיס 11 ל- 9.5, מדדי דלקת תקינים. מה מהבאים הינה הגישה הטיפולית הראשונית הטובה ביותר?

א. להתחיל טיפול בווזופרסורים (Vasopressors), במידה ואין תגובה יש לתת נוזלים באיטיות
ב. לחשב ציון SOFA או APACHE, ובהתאם לציון החלטה לגבי מתן דם
ג. להחליף APIXABAN ל- LOW MOLECULAR WEIGTH HEPARIN, ולחזור על בדיקות דם לאחר מספר שעות
ד. להתחיל טיפול בנוזלים מסוג קריסטלואידים (Crystalloid)

כל השאלות הבאות הם שאלות שלילה.

145. איזה מהממצאים המעבדתיים שלהלן **לא** מאפיין TUMOR LYSIS SYNDROME?

א. אי ספיקה כלייתית

ב. היפרקלמיה

ג. היפרקלצמיה

ד. היפראוריצמיה

146. איזה מההגידים הבאים **אינו נכון** בנוגע ל- SUPERIOR VENA CAVA SYNDROME?

א. מבין הסיבות הממאירות בקשישים ממאירות ריאה הינה הגורם השכיח ביותר

ב. סיבות שפירות יכולות להסביר קרוב למחצית מהמקרים

ג. מחלה גרורתית מהווה גורם לתסמונת במעל למחצית מהמקרים

ד. הקרנה קודמת לבית החזה יכולה לגרום לתסמונת

147. איזו אנטיביוטיקה **לא** מתאימה לטיפול אמפירי במטופל עם חום ונויטרופניה מעל שבוע?

א. CEFTAZIDIME (FORTUM)

ב. TAZOBACTAM/PIPERACILLIN (TAZOCIN)

ג. MEROPENEM

ד. AZTERONAM (AZACTAM)

148. בן 75, ברקע מחלת פרקינסון, יתר לחץ דם, אי ספיקת לב והגדלה שפירה של הערמונית. פונה למרפאה שבוע לאחר התחלת טיפול תרופתי חדש עם בצקת פריפרית חדשה.

איזו מהתרופות הבאות **לא** גרמה לכך?

א. CLONIDINE (NORMOPRESSAN)

ב. DOPICAR

ג. ALFUZOCIN (XATRAL)

ד. MILRINONE

149. איזו מהתרופות הבאות הניתנות בחולי אי ספיקת לב עם Reduced Ejection Fraction **לא** משפיעה על קצב הלב?

א. EPLERENONE

ב. IVABRADINE

ג. BISOPROLOL

ד. DIGOXIN

150. מתי **אין** לתת טיפול בניטרטים במטופל עם Non ST-ELEVATION MI?

א. היצרות קלה של המסתם האאורטלי

ב. אוטם בקיר לטרלי

ג. בצקת ריאות

ד. אוטם בחדר ימין

בהצלחה